

Physioguide — Clínica — Tríceps distal

AlKinora / Physioguide es orientativo: no sustituye criterio clínico ni diagnóstico presencial. Ningún test aislado confirma diagnóstico. No se inventan sensibilidad, especificidad ni likelihood ratios. Si la evidencia es mixta o procede de una sola serie, el texto lo indica.

Status: ACTIVE (Phase 1)

Evidence: Cluster C — extensión resistida, defecto palpable, extensión contra gravedad

Principles: Master clinical document

1. DEFINITION

Rotura del tríceps distal = fallo del tendón del tríceps en olécranon, menos frecuente que el bíceps distal. Pop posterior, debilidad de extensión de codo.

No es bursitis olecraneana sola (hinchazón posterior con extensión conservada).

2. HISTORY AND CLUSTER

- Pop o golpe posterior
- Imposibilidad o gran debilidad para extender el codo contra gravedad o resistencia
- Defecto palpable proximal al olécranon
- Equimosis posterior

POP / TRAUMA POSTERIOR

+ DÉFICIT DE EXTENSIÓN

+ DEFECTO PALPABLE

! ROTURA TRÍCEPS COMPATIBILITY ! ! IMAGEN / DERIVACIÓN

3. DIFFERENTIAL

- Bursitis olecraneana (extensión conservada)
 - Fractura de olécranon (RX)
 - Tendinopatía tricipital sin rotura (dolor, fuerza conservada)
 - Radiculopatía C7 (tríceps débil más reflejo/dermatomo, no defecto local)
-

4. AI RULES

- No hay cluster de tests especiales tan validado como el hook del bíceps.
- Déficit de extensión + defecto !' no alta como "golpe en el codo".
- No inventar Sn/Sp. Matles se cita a veces de forma análoga; no forzar analogía con Aquiles.

Citation: Revisiones de triceps tendon rupture (JSES/JAAOS). Exploración: extensión activa + palpación + imagen.

